

АСТ Регулируемые баллоны (для женщин)

Информация для пациента · Два регулируемых баллона для поддержки уретры при стрессовом недержании

WARWIKI

АСТ (Adjustable Continence Therapy) — небольшой **регулируемый** имплант для женщин со **стрессовым недержанием мочи (SUI)** — подтеканием при кашле, смехе, подъёме тяжестей или физической нагрузке. Два маленьких силиконовых баллона размещаются по обеим сторонам уретры, у шейки мочевого пузыря, мягко поддерживая её. Как и мужской аналог (ProACT), баллоны можно **настраивать в кабинете врача** после операции.

Как это действует

Стрессовое недержание возникает, когда поддержка и давление закрытия уретры ослаблены. Два баллона создают мягкую регулируемую поддержку рядом с уретрой, удерживая её закрытой при нагрузке — **не** пережимая её полностью. Каждый баллон соединён с небольшим **портом** под кожей половой губы, через который хирург регулирует наполнение.

Подходит ли мне это?

- Вариант при **стрессовом недержании мочи (SUI)**, особенно если предыдущая операция не помогла или мышца-сфинктер ослаблена (ISD)
- Хороший выбор, если вы хотите малоинвазивный, **регулируемый и обратимый** метод
- **Доступность варьируется в зависимости от страны** — применяется в специализированных центрах; уточните у своего врача
- Менее подходит при недержании, вызванном преимущественно **пролапсом** или **гиперактивным мочевым пузырём**

ТЕРМИНЫ

Стрессовое недержание

Подтекание мочи при кашле, смехе, подъёме тяжестей или нагрузке.

Шейка мочевого пузыря

Место соединения мочевого пузыря с уретрой.

Баллон

Небольшой силиконовый баллон, создающий мягкую регулируемую поддержку.

Порт

Маленький клапан под кожей половой губы для регулировки баллона.

Титрация

Постепенная настройка наполнения баллона на нескольких визитах.

ISD

Intrinsic sphincter deficiency — слабость мышцы-сфинктера уретры.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Баллоны устанавливаются во время **короткой операции** под анестезией (общей, спинальной или местной с седацией), как правило в режиме **дневного стационара** через небольшие проколы у входа во влагалище — без разрезов. Несколько дней могут быть болезненность и отёк. Последующие офисные регулировки быстрые — только небольшой укол в порт.

Как это проводят

- 1 Под анестезией под контролем **рентгена или УЗИ** хирург устанавливает по одному баллону **с каждой стороны** уретры у шейки мочевого пузыря через небольшие проколы у входа во влагалище.
- 2 Соединительные трубки выводятся к **двум портам** под кожей половых губ.
- 3 Баллоны поначалу почти пустые — в таком состоянии они заживают.

Регулировка устройства

- Через несколько недель врач добавляет немного жидкости через порт **в кабинете** — быстрый укол, без операции.
- Процедура повторяется на нескольких визитах до достижения хорошего удержания **без затруднения мочеиспускания**.
- Наполнение можно увеличивать или уменьшать; при необходимости устройство можно **удалить**.

После

- Несколько дней — небольшая болезненность, отёк или синяки; избегайте тяжёлых нагрузок.
- Удержание улучшается **постепенно** по мере настройки баллонов — не всегда сразу.
- Сообщайте будущим хирургам и специалистам по визуализации о наличии импланта.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Затруднённое мочеиспускание** или полная его задержка (баллон может быть переполнен или отёк)
- Повышение температуры, усиление боли, покраснение или выделения в области проколов (возможная инфекция)
- Новый дискомфорт во влагалище, выделения или кровь в моче (возможная эрозия)

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. АСТ использует два регулируемых баллона для поддержки уретры и уменьшения стрессового недержания — малоинвазивный и обратимый метод.
2. Баллоны устанавливаются через небольшие проколы, затем настраиваются в кабинете через порт в половой губе.
3. Применяется при повторном недержании или слабом сфинктере; доступность варьируется — обратитесь сразу, если не можете помочиться или есть признаки инфекции.